

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Spanish Chronic Disease Self-Efficacy Scale — Escala de Autoeficacia para el Manejo de Enfermedades Crónicas (SEMCD-S)

Eje VI • Versión de trabajo: 10 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1. Identificación

Familia / sigla	SEMCD-S
Nombre completo	Spanish Chronic Disease Self-Efficacy Scale (Escala de Autoeficacia para el Manejo de Enfermedades Crónicas)
Versión / edición	Versión española de 4 ítems, desarrollada directamente en español para el estudio Tomando Control de su Salud.
Idioma	Español.
Autores	Lorig KR, Ritter PL, González VM (Stanford Patient Education Research Center).
Año	2005 (publicación de referencia psicométrica; desarrollo del estudio hispano previo a esa fecha).
Tiempo estimado	no verificado

2. Eje y pregunta clínica

Eje primario	EJE VI - SALUD FÍSICA, ESTILO DE VIDA Y MEDICINA CONDUCTUAL
Etiquetas	Autoeficacia; autocuidado; enfermedad crónica; activación del paciente; medicina conductual.
Pregunta clínica que responde	¿Qué factores corporales/médicos/conductuales inciden?

3. Constructo, finalidad y usos

Constructo evaluado: autoeficacia percibida para evitar que la fatiga, las dolencias físicas, el estado emocional y otros síntomas o problemas de salud relacionados con una enfermedad crónica interfieran con las actividades que la persona desea realizar.

Finalidad: medir cambios en la autoeficacia percibida de personas con enfermedad crónica, típicamente como medida de resultado en programas de automanejo/autocuidado (p. ej. programas psicoeducativos tipo Chronic Disease Self-Management Program).

Usos apropiados:

- Evaluación de la autoeficacia percibida para el autocuidado en personas con enfermedad crónica, antes y después de intervenciones psicoeducativas.
- Investigación sobre activación del paciente y autocuidado en enfermedad crónica en población hispanohablante.
- Complemento a otros instrumentos de este acervo relacionados con adherencia (MGL/MMAS-4) y percepción de enfermedad (BIPQ) dentro de una evaluación de medicina conductual.

Usos NO apropiados:

- Medida de autoeficacia general (no relacionada con enfermedad crónica) o de autoestima.
- Sustituto del PAM-13 (Patient Activation Measure) u otras escalas de activación del paciente con derechos de licencia distintos; mide un constructo relacionado pero no idéntico (autoeficacia específica, no activación multidimensional).
- Diagnóstico de ningún trastorno; es una medida de percepción de capacidad, no de síntomas ni de funcionamiento objetivo.

4. Población, contexto, informante y modalidad

Población	Adultos hispanohablantes con una o más enfermedades crónicas.
Contexto de aplicación	Programas de automanejo/educación en salud, investigación en enfermedad crónica, atención primaria.
Informante	Autoinforme.
Modalidad de administración	Papel y lápiz o formato electrónico; individual.

5. Estructura y administración

Número de ítems	4
Periodo temporal de referencia	En este momento
Formato de respuesta	Escala numérica 1-10
Tiempo estimado de aplicación	No verificado en las fuentes consultadas (estimación editorial: 2-3 minutos, dada su brevedad).

6. Dimensiones y puntuaciones

Instrumento unidimensional: los 4 ítems (interferencia de la fatiga, de las dolencias físicas, del estado emocional, y de otros síntomas/problemas de salud) se combinan en una única puntuación de autoeficacia.

7. Sistema de puntuación

Regla de puntuación	El puntaje de cada ítem es el número marcado. Si se marcan dos números consecutivos, se codifica el menor (menor autoeficacia); si los números marcados no son consecutivos, el ítem no se puntúa. El puntaje de la escala es la media de los ítems válidos.
Ítems invertidos	No aplica; todos los ítems puntúan en el mismo sentido (mayor número = mayor autoeficacia).
Ítems omitidos / reglas de omisión	Si faltan más de dos ítems, la escala no debe puntuarse (regla general de las escalas del Self-Management Resource Center, según su documentación estándar; no se verificó si esta regla específica de omisión aparece literalmente en la hoja de 4 ítems, dado que la hoja fuente muestra la regla de 'dos números consecutivos' citada arriba).
Rango posible / puntos de corte	1-10. Mayor puntaje = mayor autoeficacia percibida. No se reportan puntos de corte clínicos de consenso en la fuente; datos descriptivos de referencia (N=551 hispanohablantes): media 6.15, DE 2.63.

8. Evidencia psicométrica en español / LatAm

Lorig KR, Ritter PL, González VM (2005). Hispanic chronic disease self-management: A randomized community-based outcome trial. *Nursing Research*, 52(6), 361-369. Consistencia interna reportada por la fuente: alfa de Cronbach = 0.933 (N=551 hispanohablantes). No se reporta fiabilidad test-retest en la ficha psicométrica consultada (marcado 'NA' en la fuente).

9. Adaptación cultural y norma local

Desarrollada y validada directamente en español (no es una traducción de la versión inglesa de 6 ítems) para el Stanford Spanish Chronic Disease Self-Management Study ('Tomando Control de su Salud'), dirigido originalmente a población hispana en Estados Unidos; no se verificó en esta sesión una adaptación normativa específica y diferenciada para España o para países concretos de Latinoamérica.

10. Límites clínicos, seguridad, derivación y no-diagnóstico

- La propia hoja fuente contiene una inconsistencia editorial (menciona 'ocho ítems' en el texto de puntuación pese a que el instrumento reproducido consta de 4 ítems); se documenta esta discrepancia explícitamente, sin inventar ítems adicionales no presentes en la fuente (ver Fuente_y_uso.md).
- Mide percepción subjetiva de capacidad (autoeficacia), no el funcionamiento objetivo real ni el manejo efectivo de la enfermedad.
- No sustituye evaluación clínica del estado de salud física ni del cumplimiento terapéutico objetivo.
- No emplear como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Fiabilidad test-retest no reportada en la fuente consultada.

11. Titular, licencia y condiciones de reproducción

El documento fuente declara explícitamente: 'This scale is free to use without permission.' Publicado por el Self-Management Resource Center (continuidad del Stanford Patient Education Research Center), smrc@selfmanagementresource.com. El Protocolo.pdf de este acervo es una reconstrucción textual verificada (no el binario original, que el entorno de red de este proceso no pudo descargar), incluyendo la advertencia sobre la inconsistencia editorial de la fuente.

12. DOI / URL oficiales y referencias APA

Lorig KR, Ritter PL, González VM (2005). Hispanic chronic disease self-management: A randomized community-based outcome trial. *Nursing Research*, 52(6), 361-369.

Self-Management Resource Center. Spanish Chronic Disease Self-Efficacy. https://selfmanagementresource.com/wp-content/uploads/Spanish_-_self-efficacy_chronic_disease.pdf

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

13. Activos disponibles, hash y estado QA

Activos disponibles	Protocolo.pdf (reconstrucción textual verificada con reportlab, 4 ítems completos + regla de puntuación + advertencia sobre inconsistencia de la fuente). Ficha Tecnica.docx / .pdf.
Hash / verificación	Ver MANIFIESTO_SHA256.csv del proyecto (generado por proceso externo posterior a esta entrega).
Estado QA	Protocolo reconstruido abre correctamente y contiene el texto íntegro verificado (comprobado con pypdf). Requiere revisión humana antes de uso clínico formal.

14. Control de versión

Fecha	2026-08-10
Responsable	Claude — proceso automatizado, requiere revisión humana
Versión de la ficha	1.0